손발바닥 발진과 매독 검사

원인불명 전신 발진에서 2기 매독을 떠올린다

가렵지 않은 다양한 발진이 손바닥·발바닥을 침범하면 매독(syphilis)을 감별한다. 2기에는 80% 이상에서 피부 발진이 나타난다.

핵심 판단의 흐름



발병 시점과 피부 소견

단계	강의의 특징
1기	감염 후 2–3주: 무통성 궤양인 경성하감, 보통 1개. 3–8주 후 자연 소실하며 서혜부 림프절이 커질 수 있다.
2기	감염 후 4–10주: 비소양성·다양한 발진, 손발바닥 침범. 편평콘딜로마·점막 미란·좀먹은 탈모.
잠복기·3기	잠복기는 피부 소견 없이 혈청검사 양성. 3기는 수년–수십 년 후 고무종·신경매독·심혈관매독.

발진 진찰과 검사 연결

진찰 항목	기억할 점
분포·동반 소견	전신 발진에 손발바닥 침범이 있는지, 점막 병변·탈모가 동반되는지 본다.
혈청검사	원인불명 전신 발진과 손발 침범이 함께 있으면 RPR 또는 VDRL을 고려한다.
시간 경과	강의는 조기매독(1·2기·조기잠복)과 만기매독(3기·만기잠복)을 1년 기준으로 구분했다.

진료실에서 기억할 점

손발바닥만 보지 말고 전신 피부·점막을 함께 관찰한다. 궤양의 자연 소실만으로 매독 가능성을 배제하지 않는다.